

Klient / Budgetnehmer: [Vorname Nachname] Geb.-Datum / KV-Nr.: [01.01.1960] [A123456789]	Pflegegrad / Status: Pflegegrad 5 (§ 36 SGB XI) Behandlungspflege: § 132l SGB V (AKI-RL)	Bezugspflegekraft / Provider: René Krieg (Pflegefachkraft AKI, Beatmungstherapeut, Pain Nurse, Wundexperte ICW)
---	---	--

Feld 0: „Was bewegt Sie im Augenblick? Was brauchen Sie? Was können wir für Sie tun?“ (Klienten- & Angehörigenperspektive)

„Ich möchte trotz meiner 24-Stunden-Beatmung in meiner gewohnten häuslichen Umgebung in Dautphetal verbleiben. Wichtig ist mir und meiner Familie eine verlässliche, hochqualifizierte Notfallbereitschaft ohne ständige Klinikeinweisungen sowie eine schmerzfreie, würdevolle Pflege im Persönlichen Budget.“

1. Kognition & Kommunikation	Invasiv über Tracheostoma beatmet. Kommunikation verbal eingeschränkt; nutzt Augensteuerung, Mimik & Ja/Nein-Buchstabentafel. Zeitlich & örtlich voll orientiert. Seh- & Hörvermögen intakt.
2. Mobilität & Beweglichkeit	Vollständige Immobile (Tetraparese/Plegie). Mobilisation 1-2x täglich im Spezialrollstuhl via Personen-Lifter. Hohes Kontrakturen- und Dekubitusrisiko; regelmäßige Wechsellagerung erforderlich.
3. Krankheitsbezogene Anforderungen (AKI)	24/7 Invasive Beatmung (Respirator). Endotracheales Absaugen nach Bedarf (aseptisch). Tracheostomapflege & Kanülenwechsel. BGA-Interpretation. Schmerz-Assessment (Pain Nurse). PEG-Stomaversorgung (Wundexperte ICW).
4. Selbstversorgung	Vollständige Übernahme der Grundpflege (Körperpflege, An/Ausziehen). Ernährung vollständig enteral über PEG-Sonde (Sondennahrung via Ernährungspumpe). Blasen-/Darmkatheter-Management.
5. Soziale Beziehungen	Lebt mit Ehefrau im Einfamilienhaus. Aktive soziale Einbindung durch Familie. Feste Ruhezeiten nachmittags gewollt. Hohes Bedürfnis nach Diskretion trotz ständiger Anwesenheit der Pflegefachkraft.
6. Haushaltsführung & Setting	Separates, barrierefreies Intensivpflegezimmer. Medizintechnische Ausstattung: 2x Beatmungsgeräte, Absauggerät, Sauerstoffkonzentrator, Notfalltasche, Notstrom-USV & Ambu-Bag voll einsatzbereit.

Fachliche Einschätzung der für die Pflege und Betreuung relevanten Risiken & Phänomene			
Risikobereich / Phänomen	Ergebnis	Fachliche Begründung & Spezifische AKI-Maßnahme	Expertenstandard
Dekubitusrisiko	JA (Braden 10)	Immobilität. 135°-Wechsellagerung alle 2-3h, Antidekubitussystem.	DNQP Dekubitus
Aspirations- & Pneumonierisiko	JA (Hoch)	Invasive Beatmung/PEG. Cuffdruck-Kontrollschablone (25-30 mbar), VAP-Prophylaxe.	G-BA AKI-RL / DNQP
Schmerzphänomene	JA (Chronisch)	Neurogene Schmerzen. BESD/NRS-Assessment (Pain Nurse), Titrationsplan.	DNQP Schmerz
Wund- & Stomarisiko	JA (Tracheo/PEG)	Aseptische Stomapflege, Feuchtigkeitsmanagement (Wundexperte ICW).	DNQP Chron. Wunden
Kontrakturen & Sturz	JA (Immobil)	Passives Durchbewegen, Lifter-Transfer mit 2 Pflegefachkräften.	DNQP Sturz / Erhalt

Koppelungsnachweis & Handlungsrichtlinie: Die nachfolgenden Pflegemaßnahmen leiten sich direkt aus den im SiS®-Bogen erfassten Themenfeldern und der Risikomatrix ab. Die Durchführung erfolgt ausschließlich durch examiniertes Pflegefachpersonal im 1:1-Setting unter Beachtung der G-BA AKI-RL und der DNQP-Expertenstandards.

Zeit / Frequenz	Kategorie / SGB	Konkrete Pflegemaßnahme & Durchführungsanweisung	Qualifikation / Standard
07:00 – 08:00 Schichtbeginn	Behandlungspflege (SGB V § 132I)	• Übergabe & Schichtübernahme. • Vitalzeichen-Check (SpO2, HF, RR, Temp). • Beatmungsparameter-Abgleich (PEEP, VT, FiO2, Pmax). • Akkutest Absauggerät & Notstrom-Funktionskontrolle.	Pflegefachkraft AKI G-BA AKI-RL
08:00 – 10:00 Morgenpflege	Grundpflege & SGB V (SGB XI / SGB V)	• Aseptisches endotracheales Absaugen nach Bedarf. • Tracheostomapflege: Kompressenwechsel, Cuffdruckkontrolle (25-30 mbar). • Ganzkörperwaschung im Bett, Hautpflege & Inkontinenzversorgung. • Aseptische Mundpflege mit Chlorhexidin zur VAP-Prophylaxe.	Wundexperte ICW DNQP Haut/VAP
10:00 – 12:00 Sondierung & Mob.	Ernährung & Mob. (SGB XI / SGB V)	• Verabreichung Sondennahrung via Ernährungspumpe (30° Oberkörperhoch). • PEG-Stomainspizierung & Spülung mit Brik-Wasser. • Mobilisation in Spezialrollstuhl via Personenlifter (2-Personen-Standard). • Passives Durchbewegen aller Gelenke zur Kontrakturenprophylaxe.	Pain Nurse / AKI DNQP Ernährung
12:00 – 15:00 Ruhephase & Check	Monitoring & BGA (SGB V § 132I)	• Schmerz-Assessment nach BESD/NRS (Pain Nurse Standard). • BGA-Kapillarblutentnahme & Auswertung bei klinischer Indikation. • 135°-Wechselagerung im Bett zur Dekubitusentlastung. • Absaugen & Befeuchtung der Atemwege via Ultraschallvernebler.	Beatmungstherapeut DNQP Schmerz
15:00 – 19:00 Abenddienst	Grund- & Behandl. (SGB XI / SGB V)	• Verabreichung Abendmedikation via PEG. • Teilkörperpflege, Lagewechsel, Hautinspektion. • Dokumentation der Tages-Tagesbilanzierung (Einfuhr/Ausfuhr). • Übergabe an den Nachtdienst.	Pflegefachkraft AKI DNQP Dekubitus
19:00 – 07:00 Nachtwache (24/7)	Intensivüberwach. (SGB V § 132I)	• Kontinuierliche Respirator- & Monitorüberwachung (SpO2/EtCO2). • Wechselagerung alle 2-3 Std. (links/rechts/Rücken). • Aseptisches Absaugen bei Alarmanzeige oder Sekretgeräuschen. • Schmerzüberwachung im Schlaf (BESD) & Bedarfsanalgesie.	Pflegefachkraft AKI 24/7 Notfallbereitschaft
24/7 Notfall Bei Alarm/Krise	Sicherheitsroutine (AKI-RL)	1. Diskonnektion/Dekanülierung: Manuelle Beatmung mit Ambu-Bag (100% O2) -> Notfall-Kanülenwechsel mit Ersatzkanüle. 2. Stromausfall: Automatische USV-Umschaltung -> Akku-Absauggerät aktivieren. 3. Arztkonsil: Kontaktaufnahme mit Notarzt/Klinik bei unstillbarer Hypoxie.	René Krieg Notfallmanagement

Evaluations- & Revisionszyklus: Die Pflegemaßnahmen werden kontinuierlich auf Wirksamkeit überprüft. Eine formelle Re-Evaluation des Maßnahmenplans findet mindestens monatlich oder bei akuter Zustandsveränderung durch die verantwortliche Pflegefachkraft René Krieg statt.

René Krieg

Verantwortliche Pflegefachkraft / AERIS Provider

[Name Klient / Gesetzlicher Vertreter]

Auftraggeber / Budgetnehmer